



世界卫生组织

中东呼吸综合征冠状病毒

2025年12月11日 | 阅读时间 11 分钟 (2958 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 中东呼吸综合征是一种由中东呼吸综合征冠状病毒引起的病毒性呼吸道疾病，2012年在沙特阿拉伯和约旦首次发现。
- 冠状病毒是一个大的病毒家族，可引起从普通感冒到严重急性呼吸综合征和2019冠状病毒病在内的各种疾病。
- 典型的中东呼吸综合征症状包括发烧、咳嗽和呼吸急促，通常会导致肺炎。
- 大约70%的新型或新出现病原体来自动物，包括可以在骆驼和人类之间传播的中东呼吸综合征冠状病毒；此后，人际传播可能导致医院和家庭暴发疾病。
- 已向世卫组织报告超过2600例实验室确诊的中东呼吸综合征冠状病毒人类感染病例；大多数（84%）来自阿拉伯半岛。
- 约有37%向世卫组织报告的中东呼吸综合征冠状病毒病例已经死亡，但这可能是高估了实际情况，因为监测系统可能会漏掉无症状或轻症病例。
- 目前还没有针对中东呼吸综合征冠状病毒的特异性治疗方法或疫苗获批。

概述

中东呼吸综合征是近年来出现的三种具有大流行潜力的高影响力人畜共患冠状病毒疾病之一。另外两种是严重急性呼吸综合征和2019冠状病毒病。冠状病毒可导致各种疾病，从普通感冒到严重呼吸道症状甚至死亡。

2012年在沙特阿拉伯和约旦首次发现中东呼吸综合征冠状病毒。此后，世卫组织各区域共有27个会员国根据《国际卫生条例（2005）》向世卫组织通报过中东呼吸综合征感染病例，其中沙特阿拉伯报告的人类病例占全部病例的84%。

中东呼吸综合征是一种人畜共患病毒，骆驼是主要宿主。受感染的骆驼不会生病，因此动物的诊断依赖于实验室检测。

自2020年以来一直有零星病例报告；它们集中在阿拉伯半岛，尤其是沙特阿拉伯。由于加强了监测、呼吸道患者分诊以及感染预防和控制，人际间传播已大大减少。

目前还没有针对中东呼吸综合征冠状病毒的特异性治疗方法或疫苗获批。这一事实再加上报告病例记录的37%的高病死率，使中东呼吸综合征冠状病毒成为世卫组织优先研究和开发的病原体。

地理分布

自2012年首次发现中东呼吸综合征冠状病毒以来，来自世卫组织所有区域的27个会员国根据《国际卫生条例（2005）》向世卫组织通报过中东呼吸综合征冠状病毒感染病例：阿尔及利亚、奥地利、巴林、中国、埃及、法国、德国、希腊、伊朗伊斯兰共和国、意大利、约旦、科威特、黎巴嫩、马来西亚、荷兰、阿曼、菲律宾、卡塔尔、大韩民国、沙特阿拉伯王国、泰国、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和也门。

中东呼吸综合征冠状病毒似乎在中东和非洲地区的骆驼种群中广泛传播，并且南亚和中亚一些国家也发现了这种病毒。最近对职业接触骆驼人群进行的血清流行率研究表明，阿拉伯半岛以外的会员国也存在人畜共患传播。

沙特阿拉伯报告的所有人类病例中超过84%曾与受感染的骆驼或医疗机构中的受感染者直接或间接接触。中东以外发现的病例看起来通常在中东感染后前往其他地区。

迄今为止，中东以外地区暴发的疫情数量有限。规模最大的一起疫情发生在2015年5月，涉及韩国一家医院。那次疫情中的指示病例有中东旅行史，此后将病毒进一步传播给医护人员和患者。结果，38名患者死亡，186人感染，韩国人经历了一场民族危机。这只是中东呼吸综合征冠状病毒进入没有准备好快速识别、检测和控制中东呼吸综合征冠状病毒的国家，对其卫生保健系统产生毁灭性影响的一个例子。

传播

大约70%的新型或新出现病原体来自动物，包括可以在骆驼和人类之间传播的中东呼吸综合征冠状病毒；人类感染可通过与骆驼的直接接触而发生，也可能因处理或食用骆驼相关原料或分泌物（例如牛奶和尿液）间接发生。

中东呼吸综合征冠状病毒可能发生人际传播，并且主要发生在密切接触者（家人和家庭成员）之间和医疗机构内部（医护人员和患者）。最大规模疫情发生在韩国、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的医疗卫生机构内。在卫生保健环境之外，人际传播一直受到限制，世界各地均未记录到持续人际传播。

医疗卫生机构记录下中东呼吸综合征冠状病毒从患者传播给医护人员并在同病房患者之间传播。这种传播常发生在确诊中东呼吸综合征冠状病毒、适当隔离患者并且医护人员遵循正确的预防措施之前。但是，早期或未经特定实验室检测并不总能识别出中东呼吸综合征冠状病毒患者，因为症状和其他临床特征与其他呼吸道疾病非常相似。

医疗卫生机构报告了聚集性病例和更大规模疫情，特别是在感染预防和控制措施不足的情况下。有效的感染预防和控制措施对于防止中东呼吸综合征冠状病毒传播至关重要。对于照顾疑似或确诊中东呼吸综合征冠状病毒感染患者的医疗机构来说，采取必要预防措施、最大限度地减少从感染患者传播给其他患者、医护人员或访客的风险至关重要。卫生和照护工作者应接受感染预防和控制方面的教育和培训，熟悉中东呼吸综合征病例定义，保持技能并随时了解该领域的新信息。

症状

中东呼吸综合征冠状病毒感染的临床表现从没有任何可检测到的症状（无症状）到轻微呼吸道症状，再到严重急性呼吸道疾病，甚至死亡。中东呼吸综合征的典型表现包括发烧、咳嗽和呼吸急促，通常发展为肺炎。还报告有包括腹泻在内的胃肠道症状。重症会导致呼吸和器官衰竭，常需要在重症监护室进行机械通气或支持治疗。

老年人（>65岁）、免疫系统较弱的人以及患有肾病、癌症、慢性肺病、高血压、心血管疾病和糖尿病等慢性疾病的人患严重或致命疾病的风险似乎更高。

治疗和预防

目前，还没有针对中东呼吸综合征冠状病毒疫苗或治疗方法获批。患者的治疗是支持性的对症治疗。不过，正在开发几种中东呼吸综合征冠状病毒特异性疫苗和治疗方法，其中一些已有开展二期临床试验的具体计划。

作为一般预防措施，参观农场、市场或其他饲养或展示动物区域的人应保持良好卫生习惯，例如在接触动物及其产品之前和之后洗手，并避免接触生病的动物。处理和食用奶和肉类等生的或者没有煮熟的动物制品会带来较高的可在人间致病的若干种病原体感染风险。通过烹饪或巴氏灭菌适当加工的动物产品应可安全食用，但也应小心处理，以避免与未熟制食品交叉污染。驼肉和驼奶属于在经过巴氏消毒、烹饪或其他加热处理后可食用的有营养的产品。

患重症风险较大的人应避免与骆驼接触、处理或饮用生驼奶或接触驼尿，或食用未正确熟制的驼肉。

旅行

世卫组织不建议实施任何与中东呼吸综合征冠状病毒有关的旅行或贸易限制或入境筛查。

世卫组织正在持续监测全球、区域和国家中东呼吸综合征冠状病毒流行病学状况，并定期更新风险评估和技术指导文件，包括有关前往哈吉和乌姆拉等报告中东呼吸综合征病例的国家参加大规模集会的指南文件和建议。在报告中东呼吸综合征冠状病毒病例的国家参加集会后返回的旅客，如果在返回后两周内出现任何急性呼吸道疾病症状，建议就医，并向卫生保健服务提供者披露最近的旅行史。

世卫组织的应对

世卫组织正在与公共卫生、动物卫生专家和国际伙伴合作，以更好地了解 and 应对中东呼吸综合征冠状病毒。所做的努力包括改善对人类和动物中中东呼吸综合征冠状病毒和其他呼吸道病原体的监测，通过“同一健康”方法加强疫情应对，并优先考虑收集科学证据的研究以促进知情决策并开发治疗方法和疫苗。世卫组织还与粮农组织、世界动物卫生组织和各国政府合作，制定预防人畜共患病传播的战略，包括为人类和骆驼提供疫苗。

全球协调包括跟踪流行病学趋势、进行风险评估、支持实地调查、提供技术指导和培训以及指导加强感染预防和控制、临床管理和治疗方法的工作。

世卫组织敦促会员国保持强有力的严重急性呼吸道感染监测，包括在已知病毒在骆驼中传播的地区进行中东呼吸综合征冠状病毒监测，审查不寻常的肺炎病例，并在医疗卫生机构采取适当感染预防和控制措施。有从中东返回的旅客或移民工人的国家应对出现症状者进行中东呼吸综合征冠状病毒检测。根据《国际卫生条例（2005）》，应向世卫组织通报所有确诊和可能的中东呼吸综合征冠状病毒病例，包括有关接触、检测和临床过程的详细信息。